六、消化性溃疡的外科治疗——胃大部切除术

（一）手术方式

切太少容易复发

1.切除胃远端≥2/3-3/4（约 60%），包括幽门和部分十二指肠球部。切断线解剖标志是小弯侧胃左动脉第一分支至大弯侧胃网膜左动脉最后一分支的连线

2.重建胃肠连续性

毕I式 胃十二指肠吻合术式	毕II式 胃空肠吻合术式
适合I型胃溃疡	适合十二指肠溃疡等
作残胃与十二指肠吻合	无酸刺激、溃疡自然好 将十二指肠残端缝闭、旷置，作残胃和近端空肠吻合，吻合口直径 3-4cm（吻口三思）
并发症少，但吻合口张力高、溃疡易复发	张力小 复发率低，但并发症多不符合原来生理情况

切不干净

吻合口太大胃内容物容易进入肠道(倾倒综合征)、太小导致排空障碍

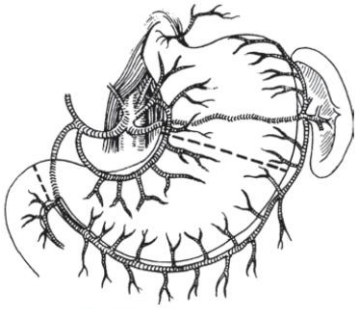


图 38-8 胃大部切除范围

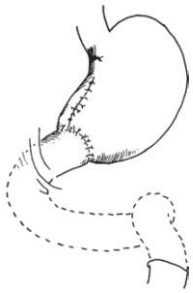


图 38-9 毕Ⅰ式胃大部切除术重建

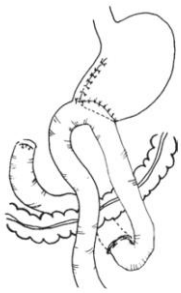


图 38-10 毕Ⅱ式胃大部切除术重建

胃与近端空肠吻合

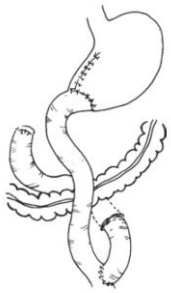


图 38-11 胃空肠 Roux-en-Y 吻合术

胃与远端空肠吻合
预防碱性反流性胃炎

3.毕II式吻合方法

输入段:胆汁流过来的地方 HP在后面追我(ME)

Hoffmeister	结肠后	输入段对胃小弯	部分胃断端
Polya	结肠后	输入段对胃小弯	全部胃断端
Moynihan	结肠前	输入段对胃大弯	全部胃断端 么么哒
Eiselsberg	结肠前	输入段对胃小弯	部分胃断端
采用结肠后方式：Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度 6-8cm（后留疤）			
采用结肠前方式：Treitz 韧带到吻合口的空肠袢长度 8-10cm（钱已还）			

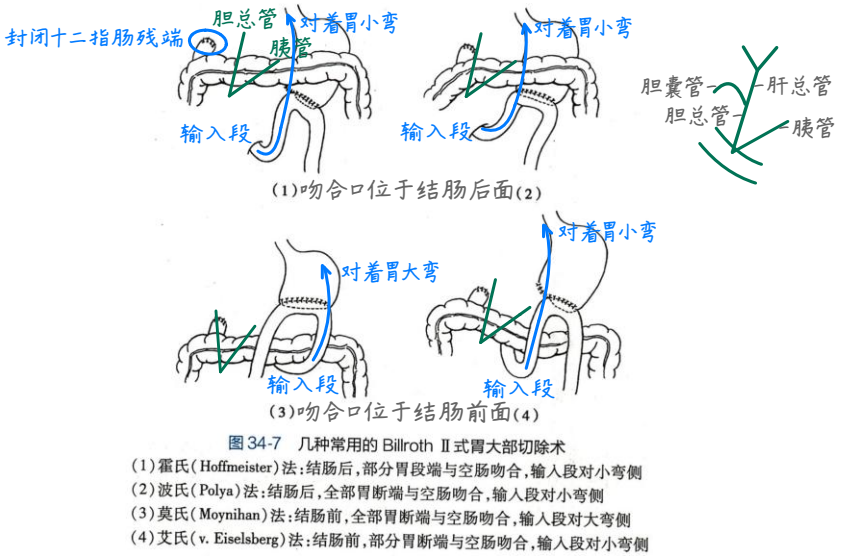


图 34-7 几种常用的 Billroth Ⅱ式胃大部切除术
(1)霍氏(Hoffmeister)法:结肠后,部分胃段端与空肠吻合,输入段对小弯侧
(2)波氏(Polya)法:结肠后,全部胃断端与空肠吻合,输入段对小弯侧
(3)莫氏(Moynihan)法:结肠前,全部胃断端与空肠吻合,输入段对大弯侧
(4)艾氏(v. Eiselsberg)法:结肠前,部分胃断端与空肠吻合,输入段对小弯侧

